UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR
FACULTÉ DE MÉDECINE

TUT'ECOS

Néphrologie
Élévation de la créatininémie
Sans patient
Sans geste clinique

Nom du rédacteur : BAILLON Tristan **Date de rédaction : Décembre 2023**

Relecture intra-ou transdisciplinaire :

Situation de départ N° 119 – Créatinine augmentée

Domaine de compétence n°1 (en sélectionner 1 SEUL) : Synthèse des résultats d'examens paracliniques

Domaine de compétence n°2 (en sélectionner 1 SEUL) : Stratégie de prise en charge

Attendus d'apprentissage de la situation abordée (cf. LISA : Catégorie:Situation de départ NG — LiSA (uness.fr)**):**

1- Prescrire de manière raisonnée les explorations complémentaires

2- Identifier les éléments cliniques et biologiques permettant de préciser la cause de l'insuffisance rénale (obstructive, fonctionnelle, organique)

3- Initier le traitement étiologique de l'insuffisance rénale et prendre en charge les complications métaboliques et cliniques

Patient simulé nécessaire à la station : NON

Matériel nécessaire à la station

- Mannequin NON
- Brancard NON
- 1 chaise, 1 table, résultat du bilan sanguin rénal dans un premier temps ; Résultat de l'échographie rénale, du ionogramme sanguin et du ionogramme urinaire dans un second temps

Instructions à l'étudiant

Vous êtes interne dans un service hospitalier de médecine polyvalente.
Vous recevez Mr X, 67 ans qui vous a été adresser par son médecin généraliste pour une élévation de la créatininémie sur son bilan sanguin annuel.
Monsieur X n'a pas d'antécédent particulier hormis des lombalgies communes depuis plusieurs années, traité par de l'Ibuprofène per os.

À l'examen clinique le patient ne présente aucune anomalie notament à l'auscultation pulmonaire.

Les constantes à l'entrée sont les suivantes : Glasgow : 15 ; PA : 120/78 mmHg ; FC 67 bpm ; FR : 20/min ; SpO2 : 97%

Vous avez **8 minutes** pour :

1. **Demander** les examens complémentaires appropriés dans cette situation d'élévation de la créatininémie.

L'examinateur vous fournira alors des examens complémentaires

2. **Interpréter** et **synthétiser** les résultats à votre disposition.
3. **Donner** la prise en charge immédiate de la complication principale retrouvée sur les examens complémentaires

UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR
FACULTÉ DE MÉDECINE

TUT'ECOS

Fiche de correction pour l'évaluateur (sans le barème)

	Cocher si fait
Tache 1	
Demande une échographie rénale *(recherche étiologie obstructive)*	
Demande un ionogramme urinaire *(recherche étiologie fonctionnelle)*	
Demande un ionogramme sanguin *(recherche étiologie fonctionnelle + complications ioniques)*	
Recherche une protéinurie + hématurie par BU	
Tache 2	
Mentionne une taille des reins normale ou supérieure à 10 cm	
Mentionne une absence de dilatation des cavités pyélo-calicielles ou une absence de formation lithiasique endo-luminale.	
Élimine une insuffisance rénale obstructive	
Élimine une insuffisance rénale fonctionnelle	
Mentionne une insuffisance rénale aiguë organique	
Justifie le caractère organique de l'IRA à l'aide de : rapport urée créat < 100, natriurèse > 40 mmol/l, rapport sodium potassium > 1, fraction d'éjection de l'urée > 35, fraction d'éjection du sodium > 1, rapport U/P urée > 10, rapport U/P créat > 30 (cite 2)	
Identifie une hyperkaliémie	
Tache 3	
Demande la réalisation d'un ECG	
Evoque l'introduction du sel de calcium selon les signes ECG (Gluconate de calcium)	
Introduit un soluté glucosé (10%) associé à de l'insuline en intra-veineuse	
Surveillance régulière de la glycémie	
Introduit du salbutamol en nébulisation	
Arrête le médicament hyperkaliémiant (Ibuprofène)	
COMPETENCES GENERIQUES	
APTITUDE À FAIRE LA SYNTHÈSE DES DONNÉES	1 à 5
APTITUDE À PROPOSER UNE PRISE EN CHARGE	

UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR
FACULTÉ DE MÉDECINE

TUT'ECOS

Fiche de correction avec le barème : non communiqué à l'évaluateur

	Pondération (entre 1 et 5)
Tache 1	
Demande une échographie rénale	4
Demande un ionogramme urinaire	2
Demande un ionogramme sanguin	2
Recherche une protéinurie + hématurie par BU	2
Tache 2	
Mentionne une taille des reins normale ou supérieure à 10 cm	2
Mentionne une absence de dilatation des cavités pyélo-calicielles	2
Élimine une insuffisance rénale obstructive	3
Mentionne un rapport urée/créatinine < 100 ou des urines peu concentrées	2
Élimine une insuffisance rénale fonctionnelle	3
Mentionne une insuffisance rénale aiguë organique	4
Identifie une hyperkaliémie	3
Tache 3	
Demande la réalisation d'un ECG	2
Introduit un sel de calcium (Gluconate de calcium)	3
Introduit un soluté glucosé (10%) associé à de l'insuline en intra-veineuse	3
Introduit du salbutamol en nébulisation	3
Arrête le médicament hyperkaliémiant (Ibuprofène)	2
	/40
COMPETENCES GENERIQUES	
APTITUDE À FAIRE LA SYNTHÈSE DES DONNÉES	1 à 5
APTITUDE À PROPOSER UNE PRISE EN CHARGE	1 à 5
Note Totale	/50